## 核心精讲 • 高血压

- 原发性/特发性/高血压病
  - 良性/缓进型
  - 恶性/急进型
- 继发性
- 特殊类型

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、缓进型/良性高血压（主要）

### （一）功能紊乱期

外周阻力↑

①**细小动脉**间歇性痉挛（波动性血压升高）VS 动脉粥样硬化好发于中、大动脉

②无器质性病变（可逆）

压力高导致血管壁机械损伤(冲烂了),血浆蛋白沉积到血管壁

### （二）特征病变——细动脉硬化/玻璃样变性

本质:蛋白质沉积

1.最易累及**肾入球动脉、视网膜、脾**

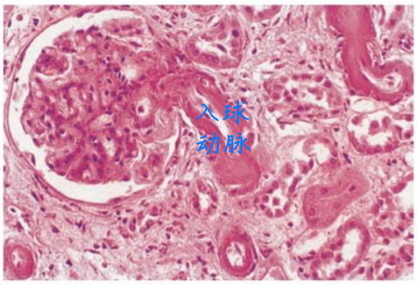


图 9-14 高血压病肾小球入球动脉玻璃样变

肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。HE染色血浆蛋白为红色

原发性颗粒固缩肾—良性高血压—入球小动脉玻璃样变性

继发性颗粒固缩肾—慢性肾小球肾炎—肾小球玻璃样变性和纤维化

2.机制做鬼也不放过你

VS 动脉粥样硬化血管内膜胆固醇沉积

①**血浆蛋白渗入血管壁**

中膜平滑肌细胞 VS 成纤维细胞产生胶原纤维

②**SMC** 分泌胶原纤维等细胞外基质

肝星状细胞本质是转变为成纤维细胞产生胶原纤维

③坏死 SMC 产生的 ttsx 修复性细胞外基质

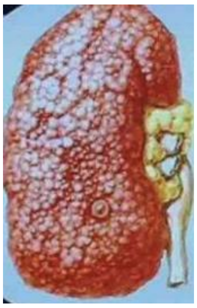
肉芽组织成纤维细胞产生胶原纤维

VS动脉粥样硬化性固缩肾(大瘢痕肾)

3.**原发性颗粒性固缩肾**：**双**肾**对称**缩小、质硬、表面凹凸不平呈细颗粒状

病变肾单位挂掉

正常肾单位代谢增强



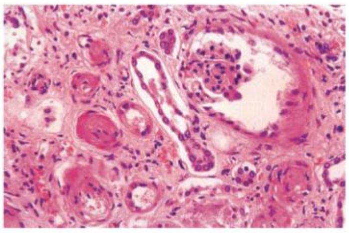


图 9-16 细动脉性肾硬化

部分肾单位纤维化、萎缩，部分肾单位代偿性肥大、扩张。

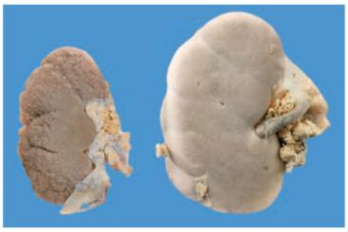
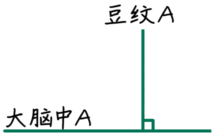


图 9-17 原发性颗粒性固缩肾

右侧为正常肾脏；左侧为原发性颗粒性固缩肾，肾脏缩小，质地变硬，肾表面凹凸不平，呈细颗粒状。

4.脑的病变



①**脑出血是高血压最严重的并发症和最常见死因**，以**基底节尤其豆状核**（豆纹动脉破裂最多见、其从大脑中动脉呈直角分支）**和内囊多见**激豆内，其次为大脑白质、脑桥、小脑。

基底节/内囊出血可以破入侧脑室

出血常为大片状、形成充满血液和坏死脑组织的囊性灶/**囊腔**，出血范围扩大时可破入脑室

脑动脉灌注压在60-140mmHg可以维持相对稳定

②**脑水肿**、**高血压脑病**（有时血压急剧升高可致**高血压危象**）、**脑软化**（**微小梗死灶**呈筛网状）、**胶质瘢痕**、**血栓形成**、**微小动脉瘤**等

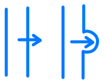
脑血栓形成,血管是不正常的 VS 脑栓塞,血管原来是正常的

VS AS累及中大A,梗死灶更大些

神经元细胞不可再生

需要胶质修复(星形胶质细胞)

不是真正的肿瘤



高血压—脑动脉玻璃样变性—管腔狭小—血流减少—氧供下降,

↓

产能降低—钠钾泵功能障碍—胞内高钠,胞内渗透压升高—细胞吸水水肿